

Nombre del Prestador :	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
Seguro	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Nombre del Paciente	HERRERA MONCADA JULIO GILBERTO
Cedula de identidad	0905786844
Historia Clínica	86844
Fecha de Ingreso	2025-10-08
Fecha de Egreso	2025-10-08
Procedimiento	ECOENDOSCOPIA + PUNCION + BIOPSIA
Diagnostico	(C25) TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS
PLANILLA DE CARGOS DEL PROVEEDOR(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA)	

HONORARIOS MEDICOS								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-08	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	1	\$160,30	\$160,30	\$0,00	\$0,0000	\$160,30
2025-10-08	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	1	\$60,60	\$60,60	\$0,00	\$0,0000	\$60,60
2025-10-08	43256	TIEMPO DE ANESTESIA	4	\$12,12	\$48,48	\$0,00	\$0,0000	\$48,48
2025-10-08	43242	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO; INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON BIOPSIA (S)/ASPIRACION POR AGUJA FINA TRANS O INTRAMURAL CON GUIA ECOENDOSCOPICA, (INCLUYE ECOENDOSCOPIA LIMITADA AL ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SI ES APROPIADO).	1	\$72,14	\$72,14	\$0,00	\$0,0000	\$72,14
2025-10-08	43236	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON INYECCION (ES) DIRECTA SUBMUCOSA, CUALQUIER SUSTANCIA.	1	\$34,46	\$34,46	\$0,00	\$0,0000	\$34,46
Total			HONORARIOS MEDICOS					\$375,98

MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-08		PROPOFOL LIQUIDO PARENTERAL EMULSION INYECTABLE 10 MG / ML AMPOLLA/FRASCO. PRESENT. 200MG/20 ML	30	\$1,04	\$31,20	\$0,00	\$0,0000	\$31,20
2025-10-08		ROCURONIO, BROMURO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML PRESENT 50MG/5ML	1	\$10,29	\$10,29	\$0,00	\$0,0000	\$10,29
2025-10-08		LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 2% PRESENT. 10 ML	1	\$1,32	\$1,32	\$0,00	\$0,0000	\$1,32
2025-10-08		BUTIL ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) - LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 20MG / ML PRESENT.20MG	1	\$1,27	\$1,27	\$0,00	\$0,0000	\$1,27
2025-10-08		ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 8MG PRESENT.8MG/4ML	1	\$3,02	\$3,02	\$0,00	\$0,0000	\$3,02
2025-10-08		FENTANILO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,05MG/10ML	1	\$0,25	\$0,25	\$0,00	\$0,0000	\$0,25
2025-10-08		DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML PRESNT. 4MG/ML	2	\$0,34	\$0,68	\$0,00	\$0,0000	\$0,68
2025-10-08		CEFTRIAXONA SOLIDO PARENTERAL POLVO PARA INYECCION 1G PRESENT. 1GR	1	\$7,63	\$7,63	\$0,00	\$0,0000	\$7,63
2025-10-08		ATROPINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 1 MG - ML PRESNT. 1ML	1	\$0,45	\$0,45	\$0,00	\$0,0000	\$0,45
2025-10-08		NEOSTIGMINA LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG / ML PRESENT 0,5 MG /1ML	4	\$0,64	\$2,56	\$0,00	\$0,0000	\$2,56
2025-10-08		KETOROLACO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION INYECTABLE 30 MG / ML PRESENT. 30 MG	2	\$2,15	\$4,30	\$0,00	\$0,0000	\$4,30
2025-10-08		OMEPRAZOL SOLIDO PARENTERAL 40 MG	1	\$5,46	\$5,46	\$0,00	\$0,0000	\$5,46
2025-10-08		CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL SOLUCION PARA INFUSION 0,9 % 1000 ML , PRESENT 1000 ML	1	\$1,93	\$1,93	\$0,00	\$0,0000	\$1,93
2025-10-08		SEVOFLURANO INHALACION. SOLUCION PARA INHALACION 1 MG/ML. PRESENT. 250ML	49	\$0,86	\$42,14	\$0,00	\$0,0000	\$42,14
Total			MEDICINAS - VALOR AL ORIGEN					\$112,50

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN								
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total
2025-10-08		OXIGENO LITROS MINUTO	300	\$0,01	\$3,00	\$0,00	\$0,0000	\$3,00
2025-10-08		Aguja de biopsia para Ecoendoscopia 19G FNB Flex, Nitinol, Diam de Aguja 2.2 mm, Long 80mm. Canal de trabajo 2.8. Estéril, Descartable	1	\$1 200,00	\$1 320,00	\$120,00	\$198,0000	\$1 518,00
2025-10-08		WALLFLEX COLONIC 25MM X 90MM DESCARTABLE	1	\$1 900,00	\$2 090,00	\$190,00	\$313,5000	\$2 403,50
2025-10-08		MICRO PINZA P T DEMUESTRA DE BIOP DESCARTABLE	1	\$550,00	\$605,00	\$55,00	\$90,7500	\$695,75
2025-10-08		BIO-GLO 10% ENDOV AMP FR 5 ML X 10 DESCARTABLE	1	\$10,00	\$11,00	\$1,00	\$1,6500	\$12,65
2025-10-08		CAP REVEAL 12.4 MM DESCARTABLE	1	\$20,00	\$22,00	\$2,00	\$3,3000	\$25,30
2025-10-08		AGUJA DE BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPIA 22G FNB FLEX, NITINOL, DIAM DE AGUJA 2.2 MM, LONG 80MM. CANAL DE TRABAJO 2.8. ESTERIL, DESCARTABLE	1	\$1 200,00	\$1 320,00	\$120,00	\$198,0000	\$1 518,00
2025-10-08		Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable	1	\$440,00	\$484,00	\$44,00	\$72,6000	\$556,60
2025-10-08		SONDA CONFOCAL AQ-FLEX UHD DESCARTABLE	1	\$4 000,00	\$4 400,00	\$400,00	\$660,0000	\$5 060,00
2025-10-08		Esfinterotomo Aguja de Corte, triple lumen, long aguja 5mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable	1	\$665,00	\$731,50	\$66,50	\$109,7250	\$841,23
2025-10-08		KIT-CIRCUITO DE ANESTESIA DESCARTABLE	1	\$13,00	\$14,30	\$1,30	\$2,1450	\$16,45
2025-10-08		ELECTRODOS 3M DESCARTABLE	3	\$0,28	\$0,93	\$0,08	\$0,1395	\$1,07
2025-10-08		BOLSA DE SUCCION DESCARTABLE	1	\$4,50	\$4,95	\$0,45	\$0,7425	\$5,69
2025-10-08		EQUIPO VENOCISIS DESCARTABLE	1	\$0,29	\$0,32	\$0,03	\$0,0480	\$0,37
2025-10-08		CATETER N°20 DESCARTABLE	1	\$0,75	\$0,83	\$0,08	\$0,1245	\$0,95
2025-10-08		MANGUERA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$2,75	\$3,03	\$0,28	\$0,4545	\$3,48
2025-10-08		JERINGAS DE 10 ML DESCARTABLE	2	\$0,11	\$0,24	\$0,02	\$0,0360	\$0,28
2025-10-08		JERINGAS DE 20 ML DESCARTABLE	2	\$0,18	\$0,40	\$0,04	\$0,0600	\$0,46
2025-10-08		Bite Block Adulto DESCARTABLE	1	\$8,00	\$8,80	\$0,80	\$1,3200	\$10,12
2025-10-08		SONDA DE SUCCION N°14 DESCARTABLE	1	\$0,90	\$0,99	\$0,09	\$0,1485	\$1,14
2025-10-08		BATA PACIENTE DESCARTABLE	1	\$1,20	\$1,32	\$0,12	\$0,1980	\$1,52
2025-10-08		BATA QUIRURGICA M DESCARTABLE	3	\$1,30	\$4,29	\$0,39	\$0,6435	\$4,93
2025-10-08		GORRO QUIRURGICOS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-08		MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLE	4	\$0,02	\$0,08	\$0,01	\$0,0120	\$0,09
2025-10-08		ZAPATONES DESCARTABLE	8	\$0,20	\$1,76	\$0,16	\$0,2640	\$2,02
2025-10-08		GUANTES MANEJO M-S DESCARTABLE	6	\$0,07	\$0,48	\$0,04	\$0,0720	\$0,55
2025-10-08		TEGADERM APOSITO DE FIJACION DESCARTABLE	1	\$0,70	\$0,77	\$0,07	\$0,1155	\$0,89
2025-10-08		LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENCION DESCARTABLE	1	\$0,30	\$0,33	\$0,03	\$0,0495	\$0,38

INSUMOS - VALOR AL ORIGEN										
2025-10-08		TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0MM DESCARTABLE			1	\$1,85	\$2,04	\$0,19	\$0,3060	\$2,35
Total					INSUMOS - VALOR AL ORIGEN					\$12 686,86
LABORATORIO										
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total		
2025-10-08	280017	OTROS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	3	\$35,96	\$107,88	\$0,00	\$0,0000	\$107,88		
Total					LABORATORIO					\$107,88
IMAGEN(*)										
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total		
Total					IMAGEN(*)					\$0,00
SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total		
2025-10-08	395162	DERECHOS DE SALA INST. SEGUNDO NIVEL	1	\$46,90	\$46,90	\$0,00	\$0,0000	\$46,90		
2025-10-08	395272	SALA DE RECUPERACION. INSTITUCIONES SEGUNDO NIVEL	1	\$26,80	\$26,80	\$0,00	\$0,0000	\$26,80		
Total					SERVICIOS INSTITUCIONALES					\$73,70
EQUIPOS ESPECIALES										
Fecha	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	10%	Iva	Total		
Total					EQUIPOS ESPECIALES					\$0,00
TOTAL LIQUIDACION										\$13 356,92



.....
DRA. AURA EDITH ZAMBRANO PAREDES
C.I. 0926862152
JEFE DE CONVENIOS PÚBLICOS
DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA
PRESTADOR EXTERNO

SERVICIO GASTROENTEROLOGIA	Fecha de Elaboración:	2025-10-08
	Área-Proceso:	AUDITORIA MEDICA
INFORME TÉCNICO-MÉDICO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS		Página: 1

DATOS GENERALES	
NOMBRES Y APELLIDOS DE PACIENTE:	JULIO GILBERTO HERRERA MONCADA
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0905786844
CÓDIGO DE VALIDACIÓN QUE AUTORIZÓ PRESTACIÓN:	CV06102025LDJS0016
FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE:	2025-10-08
MÉDICO SOLICITANTE:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD:	GASTROENTEROLOGO

DIAGNÓSTICOS (CIE-10):	
DIAGNÓSTICO(S) QUE JUSTIFICARON EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN:	C25 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS
DIGANÓSTICOS ACTUALES QUE JUSTIFICARÁN LA PRESTACIÓN ADICIONAL:	C25 TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS

CUADRO CLÍNICO DEL PACIENTE QUE JUSTIFICARÁ PRESTACIÓN ADICIONAL	
PACIENTE MASCULINO DE 72 AÑOS DE EDAD, HACE 15 DÍAS REFIERE SINTOMAS DE VÓMITOS ALIMENTICIOS DESPUÉS DE LAS COMIDAS HACE 8 DÍAS SE INTENSIFICARON POR LO QUE CADA COMIDA VOMITABA POR FUE HOSPITALIZADO EN EL IEES CEIBOS, AL MOMENTO PACIENTE NO PERMITE NADA POR VÍA ORAL, ADEMÁS REFIERE DOLOR EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO HACE 15 AÑOS A PALACIO PROFUNDO DOLOR NO SE PALPAM MASA NI VÍSCEROMEGALIAS. NIEGAS PANCREATITIS EN EL PASADO ECOGRAFÍA HACE 15 AÑOS DE CÁLCULOS EN LA VESÍCULA, TAC DE ABDOMEN Y PÉLVIS DONDE OBSERVO UN ESTÓMAGO DISTENDIDO, IMPRESIONA DE RETENCIÓN. VESÍCULA CON MÚLTIPLES LITOS. A NIVEL DE CUERPO DE PANCREAS SE OBSERVA LESIÓN QUISTICA DE GRAN TAMAÑO QUE PROVOCA COMPRESIÓN EXTRÍNICAS DE ESTRUCTURAS VECINAS. ECOGRAFÍA 30/9/2025 NÚDULOS HEPÁTICOS EDA 27/9/2025 HERNIA HIATAL POR DESLIZAMIENTO 2 CM Y GASTROPATÍA ERITOMATOSA DE NATRO COLONO NORMAL APP: HTA ENAL APRIL 10 MG APF: PAPA CIRROSIS ?? VÁRICES ESOFÁGICAS APQX: NINGUNA ALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS EXTERNOS 07/10/2025: Hemoglobina (HGB).....: 9.6 Hematocrito (HCT).....: 29.4 CLORO 103 . POTASIO 4,36 SODIO 136, BD 0,44 BT 0,79 BI 0,35 AMILASA 34 LIPASA 82 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).....: 15.4 INR.....: 1.11 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (?T?)...: 49.2 VALORACIÓN EXTERNA CARDIOLÓGICA RIESGO PREQX LEE II/IV RIESGO MODERADO Diagnóstico: C25 TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS Conclusion: -LESION QUISTICA PANCREATICA DE GRAN TAMAÑO IMPRESIONA CISTOADENOMA MUCINOSO EXTENSO DEGENERADO CON COMPRESIÓN Y ESTENOSIS DE TERCERA PORCIÓN DUODENAL SECUNDARIAMENTE + PUNCIÓN BIOPSIA + CONFOCAL + BIOPSIA CON MICRO PINZA DE PARED DEL QUISTE + ASPIRADO + COLOCACIÓN DE STENT DUODENAL PARA TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS. *NOTA: EN 15 DÍAS LABORABLES REVISAR LAS BIOPSIAS.	

PROTOCOLOS UTILIZADOS QUE JUSTIFICAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL REALIZADA:					
NO.	PROTOCOLOS	TIPO * (SELECCIONE CON UNA X)			OBSERVACIONES
		NAC	INTERN.	MBE	
1	lesión gástrica posible neoplasia.		X	X	Clinical impact of confocal laser endomicroscopy in the management of gastrointestinal lesions with an uncertain diagnosis. World J Gastrointest Endosc. 2017 Aug 16;9(8):389-395. doi: 10.4253/wjge.v9.i8.389.
2	Guías Clínicas AUGC Cáncer Gástrico Subsecretaría de Salud Pública División de prevención y Control de Enfermedades Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores		X		1. D. Max Parkin, Freddie Bray, J. Ferlay and Paola Pisani, Global Cancer Statistics, 2002 CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108 2. Ayala J.C., Lotero J.D. Tamización de cáncer gástrico Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 54 (2): 209-222, abril-junio, 2013 3. Calvo B., Alfonso Rev.Med.Clin.Condes-2011;22 (4)477-484). 4. Departamento de Estadística e Información en Salud, 2011 5. Csendes A, Smok G, Medina E, Salgado I, Rivera R, Quiral M.[Clinical course characteristics of gastric cancer 1958-1990. Rev Med Chil. 1992 Jan; 120(1):36-42. 6. Allum WH, Griffin SM, Watson A, Colin-Jones D; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; British Society of Gastroenterology; British Association of Surgical Oncology. Guidelines for the management of oesophageal and gastric cancer. Gut. 2002 Jun; 50 Suppl 5:v1-23.]
3	Quistes de colédoco			X	Topazian M. Biliary cysts. UpToDate. 2013. http://www.uptodate.com/contents/biliary-cysts 2. Mesleh M, Deziel DJ. Bile duct cysts. Surg Clin North Am. 2008; 88: 1369-1384
4	lesión gástrica posible neoplasia.		X	X	Clinical impact of confocal laser endomicroscopy in the management of gastrointestinal lesions with an uncertain diagnosis. World J Gastrointest Endosc. 2017 Aug 16;9(8):389-395. doi: 10.4253/wjge.v9.i8.389.
5	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Coordinación para la Formulación y Elaboración de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA ACALASIA		X	X	1. Goldman, Pocket Guide to the Operating Room Philadelphia: F.A. Davis Company. M.A. (3rd e.). (2008). 2. Katz PO, Gerson LB, Vela MF.Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Am J Gastroenterol. 2013 Mar; 108 (3): 308- 28. [184 referencias] PubMed 3. Longstreth, Achalasia. G.F. MD (2012). http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000267.htm. 4. Stefanidis D, W Richardson, Farrell TM, Kohn GP, Augenstein V, Fanelli RD. SAGES directrices para el tratamiento quirúrgico de la acalasia esofágica. Los Ángeles (CA): Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (sabios); 2011 mayo.50 p. [128 referencias] 5. Vaezi MF, Pandolfino JE, Vela MF. ACG guía clínica: diagnóstico y tratamiento de la acalasia. Am J Gastroenterol. 2.013 Aug; 108 (8): 1238 a 1249. [103 referencias]

6	Guías Clínicas AUGE Cáncer Gástrico Subsecretaría de Salud Pública División de prevención y Control de Enfermedades Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores		X		1. D. Max Parkin, Freddie Bray, J. Ferlay and Paola Pisani, Global Cancer Statistics, 2002 CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108 2. Ayala J.C., Lotero J.D. Tamización de cáncer gástrico Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 54 (2): 209-222, abril-junio, 2013 3. Calvo B., Alfonso Rev.Med.Clin.Condes-2011;22 (4)477- 484). 4. Departamento de Estadística e Información en Salud, 2011 5. Csendes A, Smok G, Medina E, Salgado I, Rivera R, Quitral M.[Clinical course characteristics of gastric cancer 1958- 1990. Rev Med Chil. 1992 Jan; 120(1):36-42. 6. Allum WH, Griffin SM, Watson A, Colin-Jones D; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; British Society of Gastroenterology; British Association of Surgical Oncology. Guidelines for the management of oesophageal and gastric cancer. Gut. 2002 Jun; 50 Suppl 5:v1-23.]
7	ecoendoscopia en coledocolitiasis		X	X	Diagnostic accuracy of EUS compared with MRCP in detecting choledocholithiasis: a meta-analysis of diagnostic test accuracy in head-to-head studies. Gastrointest Endosc. 2017 Dec;86(6):986- 993. doi: 10.1016/j.gie.2017.06.009. Epub 2017 Jun 20.
*TIPO: NACIONALES (NAC), INTERNACIONALES (INTERN), BUENAS PRACTICAS MÉDICAS BASADAS EN MEDICNA BASADA EN EVIDENCIA (MBE)					

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES AL AUTORIZADO QUE SERÁN JUSTIFICADOS CON ESTE INFORME:			
NO.	COD. TARIFARIO	DESCRIPCIÓN	
1	43256	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON COLOCACION TRANSENDOSCOPICA DE STENT (INCLUYE PREDILATACION).	
2	43242	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO; INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON BIOPSIA (S)/ASPIRACION POR AGUJA FINA TRANS O INTRAMURAL CON GUIA ECOENDOSCOPICA, (INCLUYE ECOENDOSCOPIA LIMITADA AL ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SI ES APROPIADO).	
3	43236	ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA PARA DIAGNOSTICO, INCLUYE ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO Y/O YEYUNO SEGUN EL CASO, CON INYECCION (ES) DIRECTA SUBMUCOSA, CUALQUIER SUSTANCIA.	
Nota: Este informe no justifica la prescripción de medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos sin la autorización debida según la normativa legal vigente para el caso, Homologaciones de procedimientos y/o laboratorios no autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, facturación indebida de acuerdo al Tarifario de Prestaciones de Salud pertinente y otras situaciones de igual similitud.			
	NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	FIRMA Y SELLO
Elaborado por:	ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO	 Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN



Nº 090578684-4

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA MONCADA

JULIO GILBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

DAULE

DAULE

FECHA DE NACIMIENTO 1953-04-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

OSIL MARIA

VILLAMAR JUANAZO



INSTRUCCIÓN

BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

JUBILADO

V1133V1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

HERRERA RIVAS FILIBERTO BERNARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MONCADA MURILLO PERPETUA ELEUTERIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2020-06-10

FECHA DE EXPIRACIÓN

2030-06-10



001580018

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO





Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 08 de Octubre del 2025

Nombre: JULIO GILBERTO HERRERA MONCADA

CI. 0905786844

Edad: 73 años

Alergia: NO

Rp:

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda

GASTROENTEROLOGO

C.I 1307189140



Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas

Fecha: Guayaquil, 08 de Octubre del 2025

Nombre: JULIO GILBERTO HERRERA MONCADA

CI. 0905786844

Edad: 73 años

Alergia: NO

Prescripción:

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

Citas médicas



042109180 - 0983753477 -0991051413/0986637750



Av. Abel R. Castillo S/N y Av. Juan Tanca Marengo,
Torre Médica I, mezanine 3, y Torre Medica II, piso 4,
consultorios 405 - 406, Ciudad del Sol(Omnihospital)

Medios Digitales



www.ieced.com.ec



@Ieced

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA			NÚMERO DE ARCHIVO				
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	0905786844							
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
							H	D	M	A
HERRERA		MONCADA	JULIO	GILBERTO	Masculino	73				x

B. DIAGNÓSTICOS

Post Operatorio:	1	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	CIE
			C25

C. PROCEDIMIENTO

	Electiva	X	Emergencia		Urgencia	
Proyectado:	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS					
Realizado:	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS					

D. INTEGRANTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Cirujano 1:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	Instrumentista:	
Cirujano 2:		Circulante:	
Primer Ayudante:	Dr(a). ALCIVAR VASQUEZ JUAN MANUEL	Anestesiologo/a:	Dr(a). ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA
Segundo Ayudante:		Ayudante Anestesia:	
Tercer Ayudante:		Otros:	

E. TIPO ANESTESIA

	General	X	Regional		Sedación		Otros	
--	---------	---	----------	--	----------	--	-------	--

F. TIEMPOS QUIRÚRGICOS

FECHA DE OPERACIÓN		DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACION
		08	10	2025	14:00:00	15:00:00
Dieresis:						
Exposición y Exploración:						
Hallazgos Quirúrgicos:						
		-LESION QUISTICA PANCREATICA DE GRAN TAMAÑO IMPRESIONA CISTOADENOMA MUCINOSO EXTENSO DEGENERADO CON COMPRESION Y ESTENOSIS DE TERCERA PORCION DUODENAL SECUNDARIAMENTE + PUNCION BIOPSIA + CONFOCAL + BIOPSIA CON MICRO PINZA DE PARED DEL QUISTE + ASPIRADO + COLOCACION DE STENT DUODENAL PARA TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS. *NOTA: EN 15 DIAS LABORABLES REVISAR LAS BIOPSIAS.				
Procedimiento Quirúrgico:						

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEO ECOENDOSCOPIO LINEAL ELECTRONICO ACOPLADO ALCAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLECON EL USO DE LOS ENDOKITS (KIT INTRODUTOR DE ECOENDOSCOPIA RADIAL) ACOPLADO AL BALON ECOENDOSCOPICO DESCARTABLE. CON AYUDA DEL SET DESCARTABLE PARA PROCESADOR DE ULTRASONIDO MAS EL SET DE PROCESADOR DE ECOENDOSCOPIA Y SE OBSERVA: EL MEDIASTINO ES NORMAL EN LA VENTANA GASTRICA LIQUIDO DE ASPECTO RETENCIONISTA QUE SE ASPIRA POR ENDOSCOPIA: HIGADO, BAZO, RIÑON SIN ALTERACIONES RELEVANTES, OBSERVAMOS UNA GRAN LESION QUISTICA CON COMPONENTE SOLIDO EN SU INTERIOR DE APROX 8 CM, QUE SE EXTIENDE DESDE CUELLO HASTA EL PROCESO UNCINADO, QUE SE COMUNICA DICHA LESION CON EL CONDUCTO PANCREATICO, CON LAAGUJA DE BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPIA 22G FNB, DIAM DE AGUJA 1.8MM, LONG 80MM. CANAL DE TRABAJO 2.8. ESTERIL, DESCARTABLESE PROCEDE A PUNCIONAR LA LESION Y SE TOMA BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO CON AGUJA DE BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPIA 19G FNB FLEX, NITINOL, DIAM DE AGUJA 2.2 MM, LONG 80MM. CANAL DE TRABAJO 2.8. ESTÉRIL, DESCARTABLE PUNCIONAMOS LA LESION Y POSTERIORMENTE CON EL KIT PROCESADOR CONFOCAL SE INTRODUCE EL SET DE INSERCIÓN LASER JUNTO CON LASONDA CONFOCAL AQ-FLEX UHD DESCARTABLE A TRAVÉS DEL CANAL OPERADO. POSTERIOR A LA INYECCIÓN DE BIO-GLO 10% ENDOV AMP FR 5 ML X 10 DESCARTABLE SE PROCEDE A REALIZAR UN ANÁLISIS A NIVEL CELULAR A 20 MICROMETROS DE PROFUNDIDAD, E IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE PROYECCIONES PAPILARES Y ADICIONALMENTE AREAS SUGESTIVAS DE DEGENERACION, CON LA MICRO PINZA P T DEMUESTRA DE BIOP DESCARTABLE TOMAMOS BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO DEL ASPIRADO DEL LIQUIDO Y LO ENVIAMOS PARA CITOLOGIA Y LABORATORIO. A NIVEL DE TERCERA PORCION DUODENAL IDENTIFICAMOS UNA ESTENOSIS POR COMPRESION DE LA LESION PANCREATICA QUE INVADE Y ESTENOSA LA TERCERA PORCION DUODENAL, POR LO QUE CON ELEsfinterotomo Aguja de Corte, triple lumen, long aguja 5mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable ACOPLADO A Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreatica 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. DescartablePROCEDEMOS A SUPERAR LA ESTENOSIS Y DEJAMOS GUIA DISTALMENTE, LUEGO CON EL RIEL RADIOPACO DESCARTABLE PROCEDEMOS A COLOCAR UNWALLFLEX COLONIC 25MM X 90MM DESCARTABLEPARA TRATAR LA ESTENOSIS. CONCLUIMOS.

G. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

NO

Pérdida Sanguínea total:

 ml Muestra:

Descripción:

H. EXÁMENES HISTOPATOLÓGICOS

Transquirúrgico:

Biopsia por congelación:

 SI NO Resultado:

Patólogo que reporta:

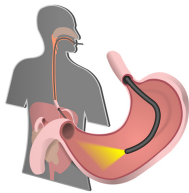
Histopatológico:

 SI

x

 NO Muestra :

I. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO



J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	FIRMA	SELLO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	GASTROENTEROLOGO		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO			
IESS				DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA				0905786844							
PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
HERRERA				MONCADA		JULIO		GILBERTO		Masculino	73	H	D	M	A
FECHA	2025-10-08	TALLA	0	PESO KG	0	IMC		GRUPO Y FACTOR		CONSENTIMIENTO INFORMADO		SI		NO	

B. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO			CIE		CIRUGÍA PROPUESTA	ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA		ESPECIALIDAD	PRIORIDAD	EMERGENTE	
DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO		TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	CIE	C25	CIRUGÍA REALIZADA	ECOENDOSCOPIA + PUNCION + BIOPSIA		GASTROENTEROLOGO		URGENTE	
ANESTESIOLOGO	ANGELICA MARIA ARRIETA BRICEÑO		AYUDANTE (S)		INSTRUMENTISTA		MILENA ASTRID RIERA HOLGUIN			QUIRÓFANO	ELECTIVO
CIRUJANO	CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		AYUDANTE (S)		JUAN MANUEL ALCIVAR VASQUEZ		CIRCULANTE				

C. SERVICIO Y PRIORIDAD DE ATENCION

CABEZA		ÓRGANOS		CUELLO		COLUMNA		TÓRAX		ABDÓMEN	X	PELVIS		EXT.SUPERIORES		EXT.INFERIORES		PERINEAL	
--------	--	---------	--	--------	--	---------	--	-------	--	---------	---	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------	--

D. REGISTRO TRANSANESTÉSICO

GASES		HORA		15	30	45	I	15	30	45	I	15	30	45	I	15	30	45	I	15	30	45	I	15
T.A.		MAX		220																				
PULSO		MIN		21																				
INDUCCIÓN		V		40																				
INCISION		A		15																				
F.N. ANESTESIA		0		160																				
CAPNOGRAFIA		0		17																				
TEMPERATURA		0		36																				
PVC		0		34																				
RESPIRACIÓN		0		120																				
ESPONTÁNEA		0		11																				
ASISTIDA		0		100																				
CONTROLADA		0		9																				
TORNIQUETE		0		80																				
PULSOXIMETRO		0		7																				
CAPNOGRAFIA		0		60																				
POSICIÓN		0		40																				
		0		30																				
		0		20																				
		0		10																				
		0		0																				

E. DROGAS ADMINISTRADAS

1	FENTANILO: 100MCG	2	LIDOCAINA AL 2%: 30MG	3	PROPOFOL: 300MG	4	ONDANSETRON: 8MG
5	OMEPRAZOL: 40MG	6	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG	7	ROCURONIO: 30MG	8	CEFTRIAXONA: 1G
9	KETOLORACO: 60MG	10	DEXAMETASONA: 8MG	11	ATROPINA: 1MG	12	NEOSTIGMINA: 2MG
13		14		15		16	

F. TÉCNICA ANESTÉSICA

GENERAL												REGIONAL												SEDO - ANALGESIA																																			
SISTEMA						APARATO						ASEPSIA CON						HABÓN CON																																									
ABIERTO		CERRADO		X		SEMICERRADO		CIRCUITO CIRCULAR		X		UNIDIRECCIONAL		LOCAL ASISTIDA						INTRAVENOSA																																							
MANEJO DE VÍA AÉREA												TRONCULAR																																															
MASCARA FACIAL				X		SUPRAGLOTICA						TRAQUEOTOMO				BLOQUEO DE NERVI						NÚMERO DE INTENTOS																																					
INTUBACIÓN												BLOQUEO DE PLEXO						NÚMERO DE INTENTOS																																									
NASAL		X		ORAL		X		SUBMENTONEANA				VISION DIRECTA				X		A CIEGAS				ANESTÉSICO LOCAL						COADYUVANTE																															
TIPO DE TUBO												TIPO DE AGUJA						EQUIPO																																									
CONVENCIONAL		X		PREFORMADO ORAL				PREFORMADO NASAL				REFORZADO		NEUROAXIAL																																													
DOBLE LUMEN		DIÁMETRO		7		BALÓN		SI		X		NO		TAPONAMIENTO		SI		NO		X		RAQUIDEA		EPIDURAL						CAUDAL		CATETER																											
EQUIPO DE INTUBACION												TIPO DE AGUJA						Nº DE INTENTOS																																									
CORMACK		I		X		II		X		III		IV		NUMERO INTENTOS				1		BORBOTAJE		SI		NO		ACCESO		MEDIAL		LATERAL		SITIO DE PUNCIÓN																											
INDUCCION						MANTENIMIENTO						DERMATOMA						POSICIÓN																																									
INHALATORIA		INTRAVENOSA		X		INHALATORIA				INTRAVENOSA				BALANCEADA		X																																											
																																		1				2		X		3				4				5				6					

G. ACCESOS VASCULARES

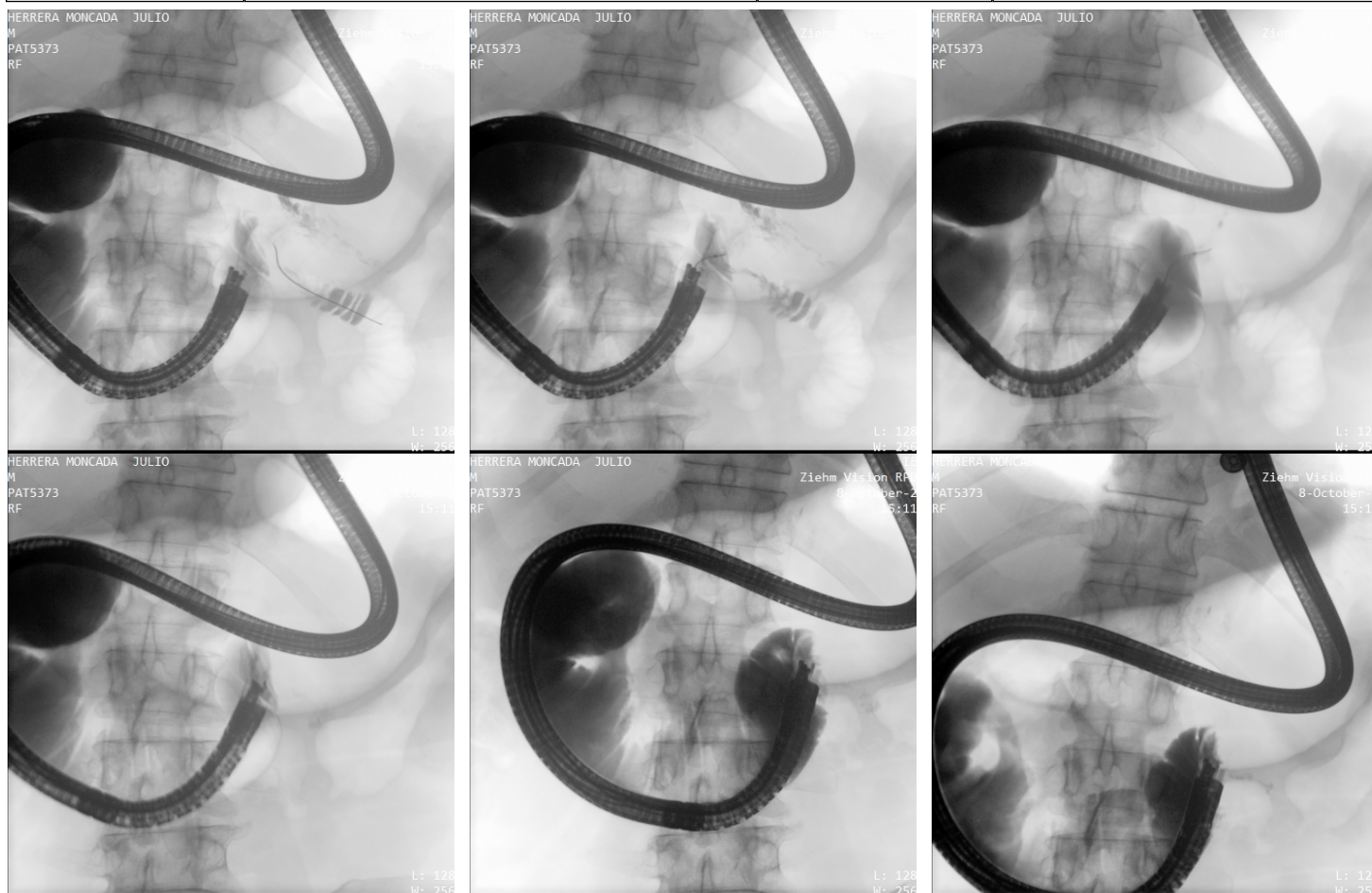
TIPO					CALIBRE					SITIO					H. REPOSICIÓN VOLÉMICA					I. PÉRDIDAS				
IV PERIFÉRICO 1					20					Miembro superior derecho					DEXTrosa 5%					SANGRE				
IV PERIFÉRICO 2															DEXTrosa 10%					PLASMA				
IV PERIFÉRICO 3															DEXTrosa 50%					PLAQUETAS				
IV CENTRAL															DEXTrosa en SS					CRIOPRECIPITADOS				
INTRA ARTERIAL															SS 0.9%					1000				
OTRO															LACTO RINGER					OTROS				
															EXPANSORES					TOTAL				
															600					BALANCE				

J. DATOS DEL RECIENTE NACIDO

APGAR										K. TIEMPOS TRANSCURRIDOS									
FETO MUERTO										DURACION ANESTESIA									
1 MINUTO										01:00:00									
5 MINUTOS										DURACION CIRUGIA									
10 MINUTOS										01:00:00									

L. TECNICAS ESPECIALES																							
HEMODILUCIÓN			AUTOTRANSFUSIÓN			HIPOTENSIÓN			HIPOTERMIA			CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA											
M. MANTENIMIENTO TEMPERATURA CORPORAL																							
MANTA TERMICA			X	CALENTAMIENTO DE FLUIDOS					OTROS														
N. INCIDENTES																							
ACTIVIDAD ELÉCTRICA SIN PULSO						ARRITMIA						ASISTOLIA						TRMBOEMBOLIA					
HIPERTERMIA MALIGNA						ANAFILAXIA						ISQUEMIA MIOCÁRDICA						NEUMOTÓRAX					
BRONCOESPASMO						DESPERTAR PROLONGADO						EMBOLIA AÉREA VENOSA						LARINGOESPASMO					
DIFICULTAD DE LA TÉCNICA						OTROS																	
O. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO																							
HORA	pH	PO2	PCO2	HCO3	EB	SAT. O2	LACTATO	GLUCOSA	Na	K	Cl	HCTO	HB	OTRO									
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
P. OBSERVACIONES																							
PACIENTE PASA A SALA DE RECUPERACIÓN EN CONDICIONES ESTABLES																							
Q. CONDICIONES DE EGRESO																							
CONDICIONES AL SALIR		EXTUBADO	X	CONDUCTIDO A	UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICO	X	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		CRÍTICOS DE EMERGENCIA		MORGUE												
		INTUBADO																					
CONSTANTES VITALES DE ENTREGA		TA	108/70mmhg	FC	75	FR	14	SAT.O2		99	T°	37											
R. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE																							
HORA	15:00:00	NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL			ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA			FIRMA	<i>Angelica H. Arrieta B.</i>			SELLO Y CÓDIGO	Dra. ARRIETA BRICEÑO ANGELICA MARIA ANESTESIOLOGIA Cedula No. 1759345422										

Paciente:	HERRERA MONCADA JULIO GILBERTO	Edad:	73 años	Identificacion:	0905786844
Procedimiento:	ECOENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA + BIOPSIA				
Referido por:		Fecha:	08/10/2025		



Hallazgos

BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEO ECOENDOSCOPIO LINEAL ELECTRONICO CON EL USO DE LOS ENDOKITS (KIT INTRODUTOR DE ECOENDOSCOPIA RADIAL) ACOPLADO AL BALON ECOENDOSCOPICO DESCARTABLE. CON AYUDA DEL SET DESCARTABLE PARA PROCESADOR DE ULTRASONIDO MAS EL SET DE PROCESADOR DE ECOENDOSCOPIA Y SE OBSERVA: EL MEDIASTINO ES NORMAL EN LA VENTANA GASTRICA LIQUIDO DE ASPECTO RETENCIONISTA QUE SE ASPIRA POR ENDOSCOPIA: HIGADO, BAZO, RIÑON SIN ALTERACIONES RELEVANTES, OBSERVAMOS UNA GRAN LESION QUISTICA CON COMPONENTE SOLIDO EN SU INTERIOR DE APROX 8 CM, QUE SE EXTIENDE DESDE CUELLO HASTA EL PROCESO UNCINADO, QUE SE COMUNICA DICHA LESION CON EL CONDUCTO PANCREATICO, CON LA AGUJA DE 22G SE PROCEDE A PUNCIONAR LA LESION Y SE TOMA BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO CON AGUJA DE 19G PUNCIONAMOS LA LESION Y POSTERIORMENTE CON EL KIT PROCESADOR CONFOCAL SE INTRODUCE EL SET DE INSERCIÓN LASER JUNTO CON LA Sonda Láser Confocal Descartable AQFLEX DE 0.8 MM A TRAVÉS DEL CANAL OPERADO. POSTERIOR A LA INYECCIÓN CON SET DE FLUORESCENCIA ESTÉRIL + ACRIFLAVINA SE PROCEDE A REALIZAR UN ANÁLISIS, CON AYUDA DEL ADAPTADOR CAP, A NIVEL CELULAR A 20 MICROMETROS DE PROFUNDIDAD, E IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE PROYECCIONES PAPILARES Y ADICIONALMENTE AREAS SUGESTIVAS DE DEGENERACION, CON LA PINZA TIPO MORAY TOMAMOS BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO DEL ASPIRADO DEL LIQUIDO Y LO ENVIAMOS PARA CITOLOGIA Y LABORATORIO. A NIVEL DE TERCERA PORCION DUODENAL IDENTIFICAMOS UNA ESTENOSIS POR COMPRESION DE LA LESION PANCREATICA QUE INVADE Y ESTENOSA LA TERCERA PORCION DUODENAL, POR LO QUE CON EL ESFINTEROTOMO ACOPLADO A HILO GUIA METALICO PROCEDEMOS A SUPERAR LA ESTENOSIS Y DEJAMOS HILO GUIA DISTALMENTE, LUEGO CON EL CATETER RIEL RADIOPACO DESCARTABLE PROCEDEMOS A COLOCAR UN STENT DUODENAL DE 25X90 MM PARA TRATAR LA ESTENOSIS. CONCLUIMOS.

Conclusiones

LESION QUISTICA PANCREATICA DE GRAN TAMAÑO IMPRESIONA CISTOADENOMA MUCINOSO EXTENSO DEGENERADO CON COMPRESION Y ESTENOSIS DE TERCERA PORCION DUODENAL SECUNDARIAMENTE + PUNCION BIOPSIA + CONFOCAL + BIOPSIA MORAY DE PARED DEL QUISTE + ASPIRADO + COLOCACION DE STENT DUODENAL PARA TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS.

NOTA: EN 15 DIAS LABORABLES REVISAR LAS BIOPSIAS.

Dr. Carlos Antonio Robles Medranda
GASTROENTEROLOGO
C.I 1307189140

CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE

INSTITUCION DEL SISTEMA		UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA				NÚMERO DE ARCHIVO								
IESS		26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0905786844												
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO		EDAD		CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
														H	D	M	A
HERRERA		MONCADA		JULIO		GILBERTO		1953-04-12		Masculino		73					X

B. DATOS DEL SERVICIO Y PRIORIDAD

SERVICIO				ESPECIALIDAD		PRIORIDAD			HORA DE TOMA	FECHA DE TOMA		
EMERGENCIA		CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACIÓN		GASTROENTEROLOGO	URGENTE		RUTINA	X		08/10/2025

C. ESTUDIO SOLICITADO

HISTOPATOLOGÍA	X	CITOLOGÍA		REVISIÓN DE LAMINILLAS		TRANSOPERATORIO		OTROS TIPO DE ESTUDIO:		
----------------	---	-----------	--	------------------------	--	-----------------	--	------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN

Se toma biopsia de BIOPSIA DE PARED QUISTICA PANCREATICA, BIOPSIAS DE PARED DE LESION QUISTICA, ASPIRADO DE CITOLOGIA LESION QUISTICA PANCREATICA

D. RESUMEN CLÍNICO

REGISTRAR DE MANERA OBLIGATORIA TODOS LOS CAMPOS

CUADRO CLÍNICO

PACIENTE MASCULINO DE 72 AÑOS DE EDAD, HACE 15 DIAS REFIERE SINTOMAS DE VOMITOS ALIMENTICIOS DESPUES DE LAS COMIDAS HACE 8 DIAS SE INTENSIFICARON POR LO QUE CADA COMIDA VOMITABA POR FUE HOSPITALIZADO EN EL IEES CEIBOS, AL MOMENTO PACIENTE NO PERMITE NADA POR VIA ORAL, ADEMAS REFIERE DOLOR EN HIPOCONDRIIO IZQUIERDO HACE 15 A;OS A PALACION PROFUNDA DOLOR NO SE PALPAM MASA NI VISEROMEGALIAS. NIEGAS PANCREATITIS EN EL PASADO

ECOGRAFIA HACE 15 AÑOS DE CALCULOS EN LA VESICULA, TACDE ABDOMEN Y PELVIS DONDE OBSERVO UN ESTOMAGO DISTENDIDO, IMPRESIONA DE RETENCION. VESICULA CON MULTIPLES LITOS. A NIVEL DE CUERPO DE PANCREAS SE OBSERVA LESION QUISTICA DE GRAN TAMAÑO QUE PROVOCA COMPRESION EXTRINCICAS DE ESTRUCTURAS VECINAS.

ECOGRAFIA 30/9 NODULOS HEPATICOS

EDA 27/9/2025 HERNIA HIATAL POR DESLIZAMIENTO 2 CM Y GASTROPATIA ERITOMATOSA DE NATRO

COLONO NORMAL

07/10/2025

Hemoglobina (HGB).....: 9.6 Hematocrito (HCT).....: 29.4CLORO 103 . POTASIO 4,36 SODIO 136, BD 0,44 BT 0,79 BI 0,35 AMILASA 34 LIPASA 82 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).....: 15.4 INR..... 1.11 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (?T?)...: 49.2

RIESGO PREQX LEE II/IV

RIESGO MODERADO

APP: HTA ENALAPRIL 10 MG

APF: PAPA CIRROSIS ?? VARICES ESOFAGICAS

APQX: NINGUNA

ALERGIAS: NO

RESULTADOS DE LABORATORIO

DATOS DE IMAGEN

TRATAMIENTO

PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA OBTENCIÓN MUESTRA

ECOENDOSCOPIA + PUNCION + BIOPSIA

E. DIAGNOSTICOS

PRE=PRESENTIVO
DEF=DEFINITIVO

CIE PRE DEF

F. MUESTRA O PIEZA /
NUMERO

DESCRIBIR EL ORIGEN Y
NUMERO DE MUESTRAS ENVIADAS

1.	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25		X	BIOPSIA DE PARED QUISTICA PANCREATICA
2.					BIOPSIAS DE PARED DE LESION QUISTICA
3.					ASPIRADO DE CITOLOGIA LESION QUISTICA PANCREATICA
4.					
5.					

G. DATOS BÁSICOS PARA CITOLOGÍA VAGINAL

MATERIAL						ANTICONCEPCIÓN				TERAPIA HORMONAL	EDAD DE:			PARIDAD				FECHAS			
ENDOCERVIX	EXOCERVIX	VAGINAL	ENDOMETRIAL	OTROS	NINGUNA	HORMONAL	DIU	LIGADURA	OTRO		MENARQUIA	MENOPAUSIA	INICIO DE RELACIONES SEXUALES	GESTACIONES	PARTOS	ABORTOS	CESÁREAS	ÚLTIMA MENSTRUACIÓN	ÚLTIMO PARTO	ÚLTIMA CITOLOGÍA	
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA																		DIAGNÓSTICO DE ÚLTIMA CITOLOGÍA:			

H. BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA

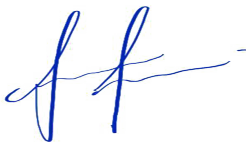
I. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

FECHA (aaaa-mm-dd)	HORA DE SOLICITUD (hh:mm)	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-08	10:52:28	CARLOS	ROBLES	MEDRANDA

I. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		FIRMA		SELLO
1307189140				Dr(a). ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO MSP No. 1307189140
FECHA DE RECEPCIÓN (aaaa-mm-dd)	HORA DE RECEPCIÓN (hh:mm)	NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUIEN ENTREGA LA MUESTRA	NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUIEN RECIBE LA MUESTRA	CÓDIGO INTERNO DE MUESTRA

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO USUARIO / PACIENTE										
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICODIGO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NUMERO DE HISTORIA CLINICA	NUMERO DE ARCHIVO		No.HOJA			
IESS	26699	DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0905786844						
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)				
						H	D	M	A	
HERRERA	MONCADA	JULIO	GILBERTO	Masculino	73					x

B. EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES									
1. EVOLUCIÓN					2. PRESCRIPCIONES				
FECHA (aaaa- mm - dd)	HORA (hh:mm)	NOTAS DE EVOLUCIÓN	FARMACOTERAPIA E INDICACIONES(Para enfermería y otro profesional de salud)			ADMINISTR. FARMACOS Y DISPOSITIVOS			
08/10/2025	12:00	PACIENTE MASCULINO DE 72 AÑOS DE EDAD, HACE 15 DIAS REFIERE SINTOMAS DE VOMITOS ALIMENTICIOS DESPUES DE LAS COMIDAS HACE 8 DIAS SE INTENSIFICARON POR LO QUE CADA COMIDA VOMITABA POR FUE HOSPITALIZADO EN EL IEES CEIBOS, AL MOMENTO PACIENTE NO PERMITE NADA POR VIA ORAL, ADEMAS REFIERE DOLOR EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO HACE 15 A;OS A PALACION PROFUNDA DOLOR NO SE PALPAM MASA NI VISEROMEGALIAS. NIEGAS PANCREATITIS EN EL PASADO ECOGRAFIA HACE 15 AÑOS DE CALCULOS EN LA VESICULA, TAC DE ABDOMEN Y PELVIS DONDE OBSERVO UN ESTOMAGO DISTENDIDO, IMPRESIONA DE RETENCION. VESICULA CON MULTIPLES LITOS. A NIVEL DE CUERPO DE PANCREAS SE OBSERVA LESION QUISTICA DE GRAN TAMAÑO QUE PROVOCA COMPRESION EXTRINCICAS DE ESTRUCTURAS VECINAS. ECOGRAFIA 30/9/2025 NODULOS HEPATICOS EDA 27/9/2025 HERNIA HIATAL POR DESLIZAMIENTO 2 CM Y GASTROPATIA ERITOMATOSA DE NATRO COLONO NORMAL APP: HTA ENALAPRIL 10 MG APF: PAPA CIRROSIS ?? VARICES ESOFAGICAS APQX: NINGUNA ALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS EXTERNOS 07/10/2025: Hemoglobina (HGB).....: 9.6 Hematocrito (HCT).....: 29.4CLORO 103 . POTASIO 4,36 SODIO 136, BD 0,44 BT 0,79 BI 0,35 AMILASA 34 LIPASA 82 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).....: 15.4 INR..... 1.11 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (?T?)...: 49.2 VALORACION EXTERNA CARDIOLOGICA RIESGO PREQX LEE II/IV RIESGO MODERADO	1.- CSV 2.- PREPARAR PARA PROCEDIMIENTO 3.- SOL SAL 0,9% 1000cc a 30gts x min 4.-SEGUIR INDICACIONES DE MEDICO RESIDENTE 5.-SE SOLICITA EXAMENES PRE-QUIRURGICOS						
08/10/2025	15:00	PASE A SALA DE RECUPERACION DESPUES DE PROCEDIMIENTO CON SIGNOS VITALES ESTABLES.	1.- BUTIL BROMURO DE HIOSCINBA IV PRN 2.- SEGUIR INDICACIONES						
08/10/2025	16:00	PACIENTE EGRESA ESTABLE HEMODINAMICAMENTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS ENDOSCÓPICOS. PCTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DESPUES DEL PROCEDIMIENTO. SE MANTIENE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE. CLINICAMENTE BIEN. SE DA ALTA, SE EXPLICAN LOS RESULTADOS A PACIENTE Y ACOMPAÑANTE. SE ENTREGAN INDICACIONES AL ALTA.							



Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
GASTROENTEROLOGO
cedula No. 1307189140

A. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y USUARIO / PACIENTE									
INSTITUCIÓN DEL SISTEMA	UNICÓDIGO		ESTABLECIMIENTO DE SALUD		NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA		NÚMERO DE ARCHIVO		No. HOJA
IESS	26699		DR. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA		0905786844				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEXO	EDAD	CONDICIÓN EDAD (MARCAR)			
						D	H	M	A
HERRERA	MONCADA	JULIO	GILBERTO	MASCULINO	73				X

B. RESUMEN DE CUADRO CLINICO									
PACIENTE MASCULINO DE 72 AÑOS DE EDAD, HACE 15 DIAS REFIERE SINTOMAS DE VOMITOS ALIMENTICIOS DESPUES DE LAS COMIDAS HACE 8 DIAS SE INTENSIFICARON POR LO QUE CADA COMIDA VOMITABA POR FUE HOSPITALIZADO EN EL IEES CEIBOS, AL MOMENTO PACIENTE NO PERMITE NADA POR VIA ORAL, ADEMAS REFIERE DOLOR EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO HACE 15 AÑOS A PALACION PROFUNDA DOLOR NO SE PALPAM MASA NI VESIGOMEGALIAS. NIEGAS PANCREATITIS EN EL PASADO ECOGRAFIA HACE 15 AÑOS DE CALCULOS EN LA VESICULA, TAC DE ABDOMEN Y PELVIS DONDE OBSERVO UN ESTOMAGO DISTENDIDO, IMPRESIONA DE RETENCION. VESICULA CON MULTIPLES LITOS. A NIVEL DE CUERPO DE PANCREAS SE OBSERVA LESION QUISTICA DE GRAN TAMAÑO QUE PROVOCA COMPRESION EXTRINSECAS DE ESTRUCTURAS VECINAS. ECOGRAFIA 30/9/2025 NODULOS HEPATICOS EDA 27/9/2025 HERNIA HIATAL POR DESLIZAMIENTO 2 CM Y GASTROPATIA EROSIOMATOSA DE NATRO COLONO NORMAL APP: HTA ENALAPRIL 10 MG APF: PAPA CIRROSIS ?? VARICES ESOFAGICAS APQX: NINGUNA ALERGIAS: NO REFIERE LABORATORIOS EXTERNOS 07/10/2025: Hemoglobina (HGB).....: 9.6 Hematocrito (HCT).....: 29.4CLORO 103 . POTASIO 4,36 SODIO 136, BD 0,44 BT 0,79 BI 0,35 AMILASA 34 LIPASA 82 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP).....: 15.4 INR.....: 1.11 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (?T?)...: 49.2 VALORACION EXTERNA CARDIOLOGICA RIESGO PREQX LEE II/IV RIESGO MODERADO									

C. RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES	
Evolución	Complicación
FAVORABLE	NINGUNA

D. HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS	
-LESION QUISTICA PANCREATICA DE GRAN TAMAÑO IMPRESIONA CISTOADENOMA MUCINOSO EXTENSO DEGENERADO CON COMPRESION Y ESTENOSIS DE TERCERA PORCION DUODENAL SECUNDARIAMENTE + PUNCION BIOPSIA + CONFOCAL + BIOPSIA CON MICRO PINZA DE PARED DEL QUISTE + ASPIRADO + COLOCACION DE STENT DUODENAL PARA TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS. *NOTA: EN 15 DIAS LABORABLES REVISAR LAS BIOPSIAS.	

DATOS DEL USUARIO / PACIENTE				
PRIMER APELLIDO	PRIMER NOMBRE	EDAD	NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA	NÚMERO DE ARCHIVO
HERRERA	JULIO	73	0905786844	

E. RESUMEN DE TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS
BAJO ANESTESIA GENERAL SE INTRODUCE EL VIDEO ECOENDOSCOPIO LINEAL ELECTRONICO ACOPLADO AL CAP REVEAL 12,4 MM DESCARTABLE A TRAVES DE BITE BLOCK ADULTO DESCARTABLE CON EL USO DE LOS ENDOKITS (KIT INTRODUCTOR DE ECOENDOSCOPIA RADIAL) ACOPLADO AL BALON ECOENDOSCOPICO DESCARTABLE. CON AYUDA DEL SET DESCARTABLE PARA PROCESADOR DE ULTRASONIDO MAS EL SET DE PROCESADOR DE ECOENDOSCOPIA Y SE OBSERVA: EL MEDIASTINO ES NORMAL EN LA VENTANA GASTRICA LIQUIDO DE ASPECTO RETENCIONISTA QUE SE ASPIRA POR ENDOSCOPIA: HIGADO, BAZO, RIÑON SIN ALTERACIONES RELEVANTES, OBSERVAMOS UNA GRAN LESION QUISTICA CON COMPONENTE SOLIDO EN SU INTERIOR DE APROX 8 CM, QUE SE EXTIENDE DESDE CUELLO HASTA EL PROCESO UNCINADO, QUE SE COMUNICA DICHA LESION CON EL CONDUCTO PANCREATICO, CON LA AGUJA DE BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPIA 22G FNB, DIAM DE AGUJA 1.8MM, LONG 80MM. CANAL DE TRABAJO 2.8. ESTÉRIL, DESCARTABLE SE PROCEDE A PUNCIONAR LA LESION Y SE TOMA BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO CON AGUJA DE BIOPSIA PARA ECOENDOSCOPIA 19G FNB FLEX, NITINOL, DIAM DE AGUJA 2.2 MM, LONG 80MM. CANAL DE TRABAJO 2.8. ESTÉRIL, DESCARTABLE PUNCIONAMOS LA LESION Y POSTERIORMENTE CON EL KIT PROCESADOR CONFOCAL SE INTRODUCE EL SET DE INSERCIÓN LASER JUNTO CON LA Sonda CONFOCAL AQ-FLEX UHD DESCARTABLE A TRAVÉS DEL CANAL OPERADO. POSTERIOR A LA INYECCIÓN DE BIO-GLO 10% ENDOV AMP FR 5 ML X 10 DESCARTABLE SE PROCEDE A REALIZAR UN ANÁLISIS A NIVEL CELULAR A 20 MICROMETROS DE PROFUNDIDAD, E IDENTIFICAMOS LA PRESENCIA DE PROYECCIONES PAPILARES Y ADICIONALMENTE AREAS SUGESTIVAS DE DEGENERACION, CON LA MICRO PINZA P T DEMUESTRA DE BIOP DESCARTABLE TOMAMOS BIOPSIAS DE LA PARED, LUEGO DEL ASPIRADO DEL LIQUIDO Y LO ENVIAMOS PARA CITOLOGIA Y LABORATORIO. A NIVEL DE TERCERA PORCION DUODENAL IDENTIFICAMOS UNA ESTENOSIS POR COMPRESION DE LA LESION PANCREATICA QUE INVADE Y ESTENOSA LA TERCERA PORCION DUODENAL, POR LO QUE CON EL Esfinterotomo Aguja de Corte, triple lumen, long aguja 5mm con aislante, long 200cm Estéril. Descartable ACOPLADO A Guía de Nitinol hidrofílica para vías biliares/pancreática 0,035 x 450cm longitud recta Estéril. Descartable PROCEDEMOS A SUPERAR LA ESTENOSIS Y DEJAMOS GUIA DISTALMENTE, LUEGO CON EL RIEL RADIOPACO DESCARTABLE PROCEDEMOS A COLOCAR UN WALLFLEX COLONIC 25MM X 90MM DESCARTABLE PARA TRATAR LA ESTENOSIS. CONCLUIMOS.

F. INDICACIONES DE ALTA / EGRESO
PRÓXIMO CONTROL

G. DIAGNOSTICO DE ALTA / EGRESO		CIE
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25
CAUSA EXTERNA		

H. CONDICIÓN DE ALTA / EGRESO					VIVO	FALLECIDO
ALTA MÉDICA	X	DISCAPACIDAD		RETIRO NO AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MENOS DE 48 HORAS	DÍAS DE ESTADIA
ALTA VOLUNTARIA				AUTORIZADO	DEFUNCIÓN MAS DE 48 HORAS	DÍAS DE REPOSO

I. MÉDICOS TRATANTES			
NOMBRE Y APELLIDOS		ESPECIALIDAD	PERÍODO DE RESPONSABILIDAD
1.	Dr. CARLOS ANTONIO ROBLES MEDRANDA	GASTROENTEROLOGO	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140

J. DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE				
FECHA	HORA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
2025-10-08		Dr. CARLOS	ROBLES	MEDRANDA
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		FIRMA		SELLO
1307189140				Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO GASTROENTEROLOGO Cedula No. 1307189140
ELABORADO POR:		Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO	REVISADO POR:	Dr. ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO